

杂志, 2000, 16(9): 520.

[3] Baulieu EE. Science, 1989, 245: 1351—1353.

[4] 徐苓. 子宫肌瘤非手术治疗的理论基础及适应证[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2001, 17(3): 129.

文章编号: 1006—6233(2002)09—0859—02

药物相互作用对地高辛血药浓度监测的影响

何志敏, 丁志敏

(承德医学院附属医院, 河北 承德 067000)

地高辛(Digoxin DGX)是临床上治疗心脏疾病的强心甙类药物之一, 由于作用机理复杂, 药效强, 治疗剂量接近中毒剂量, 其用量不足和剂量偏高的临床表现又很相似, 且个体差异大等原因, 临床上需要进行血药浓度监测, 用以指导临床制定个体化给药方案。临床上进行地高辛(DGX)血药浓度监测, 我们已坚持多年, 监测人数达上千人。

在临床应用上, 一些心力衰竭和心律失常的病人通常需长期服用地高辛, 且时常与其它药物联合使用。有的住院病人药物合用多达十几种。这种合用有可能导致不良的相互作用, 使 DGX 血药浓度升高过多, 发生洋地黄中毒; 或 DGX 浓度降低过多, 出现洋地黄化不足。了解它们之间的相互影响, 这对临床合理用药具有很重要的意义。本文主要讨论药物相互作用对地高辛血药浓度监测的影响。

1 加强或延长地高辛作用, 使血药浓度升高的药物

1.1 红霉素、四环素

可抑制肠道菌丛, 减少肠道菌丛对地高辛的代谢降解, 引起地高辛血药浓度升高。有人报道, 3 名受试者加服红霉素或四环素 5d 后, 血清地高辛升高 43~116%, 一患者连续四次服用红霉素 250mg, 结果发生地高辛中毒。

1.2 普鲁本辛

抗胆碱能药普鲁本辛与低溶出率的地高辛片剂同服时, 导致地高辛血药浓度升高 30%; 与较高溶出速率的地高辛片剂同服时, 地高辛浓度变化不明显。这是由于普鲁本辛可减弱胃肠的蠕动, 使得低溶出速率的地高辛片剂溶出量增多, 生物利用度增加。

1.3 胺碘酮、奎尼丁、异博定、安定、颠茄、胃苏平

不仅加强或延长了地高辛作用, 血药浓度升高, 而且不良反应增加。药物的肾排泄减少。因肾小管重吸收增加, 或两药竞争肾小管分泌, 使药物半衰期延长。明显改变药物分布容积。加强观察或监测血药浓度。注意适当调整剂量(特别注意当影响药开始使用或停用后被影响药的用量需调整)胺碘酮与地高辛的这种相互作用在儿童身上表现的更加明显和强烈。

1.4 维拉帕米、硫甲丙脯酸、安体舒通、三氨喋呤、利尿酸钠、环孢霉素、硝苯地平

以上药物清除率降低。半衰期明显延长。明显改变分布容积。因此, 应适量减少地高辛用量。

维拉帕米可使血清地高辛浓度升高 60~80%, 消除半衰期延长 12h 左右。39 例风湿性心脏病房颤患者联用两药的临床观察表明, 两药联用后 3d, 地高辛血药浓度即出现有意义增加, 7d 达高峰并趋于持续稳定。

安体舒通可抑制地高辛在肾小管的分泌, 它与奎尼丁联用时对地高辛药动学的影响更大。对照实验表明, 安体舒通、奎尼丁和地高辛三者合用, 可导致地高辛总清除率、肾清除率及非肾清除率显著降低, 比各自单独与地高辛合用时影响更大。因此安体舒通和地高辛合用时应减少地高辛用量, 三者合用则应进一步减量并进行监测。

有关硝苯地平与地高辛相互作用的报道不一: 在一些实验中, 健康

受试者每日口服硝苯地平 30mg, 引起地高辛血药浓度升高 46%, 肾清除率下降 29%。但另一些实验却未观察到硝苯地平对地高辛清除率和浓度的影响。这种差异可能与实验设计、剂量方案及研究数量有关^[1]。

1.5 环孢霉素、地尔硫卓、保泰松、甲氧脲胍

以上药物加强或延长地高辛作用, 血药浓度增高。机理是抑制肝药酶, 使药物的浓度增加, 半衰期延长。

有报道, 应用地高辛的患者, 在接受心脏移植术前给予环孢霉素, 患者出现了肾功能不全和血清地高辛浓度的显著提高。其中有的超出原先水平的 3 倍。作用机理目前尚不明确。环孢霉素也是肝药酶抑制剂, 故推测可能与地高辛的肝脏代谢受到抑制有关。

硫氮卓酮一般用量或短期使用无明显影响。用量大或高浓度或长期使用, 加强或延长地高辛作用。血药浓度升高。它是一种潜在的肝药酶抑制剂^[2]。

1.6 氯化钙、葡萄糖酸钙

与地高辛联用有助于提高疗效, 加强或延长地高辛作用。血浓度过高, 可能出现毒性反应。可引起心律失常。最好避免静脉给药, 必须用时应缓慢滴注^[3]。

2 降低或缩短地高辛作用, 使血药浓度降低的药物

2.1 柳氮磺吡啶、新霉素、对氨基水杨酸

可能是通过改变肠壁特性而减少地高辛的吸收度和程度, 血药浓度大约比地高辛稳态浓度降低 20~30%。

2.2 癌症化疗药物

环磷酰胺、长春新碱、5-氟尿嘧啶、氨甲喋呤、阿糖胞苷和阿霉素等, 可损伤肠道黏膜, 减少地高辛的吸收。血清地高辛浓度降低, 而换以地高辛溶液或胶囊剂, 可有效地避免这种不良作用。

2.3 利福平、苯妥英钠

以上药物是较强的肝药酶诱导剂, 可通过诱导肝药酶而促进地高辛在肝脏内的代谢, 使血清地高辛的浓度下降。

2.4 硝普钠、胍苯酚嗪、左旋多巴

以上药物与地高辛合用后, 地高辛血药浓度降低, 是由于它们促进了地高辛在肾小管的分泌, 肾清除率增加。

2.5 氢氧化铝、胃舒平、药用炭、氮芥、噻替哌

以上药物降低或缩短地高辛作用。口服时胃肠道吸收受阻, 降低血清地高辛浓度。

综上所述, 地高辛能和许多与其联用的药物发生药动学相互作用。因此, 我们在分析地高辛血药浓度结果的同时, 还要考虑到药物相互作用的问题。故临床用药时, 应适当调整地高辛剂量, 或改用其它剂型、其它种类的药物, 或间隔一定时间分开服用, 以确保安全、有效用药。

参考文献:

[1] 张家利, 伍沪生, 李清朗. 硫氮卓酮与地高辛联合服用对血清地高辛浓度的影响[J]. 中华内科杂志, 1990, 29: 646—648.

[2] 印绮平, 王宏图, 张静华. 地高辛的相互作用及其机理[J]. 现代应用药学, 1976, 14: 1-3.

[3] 殷民德, 朱华. 地高辛和卡托普利相互作用的监测[J]. 中国医院药学杂志, 1993, 13: 65-66.

中医中药

文章编号: 1006-6233(2002)09-0860-01

葛根汤加减治疗颈椎病临床观察

焦 瑛

(河北省国土资源厅门诊部, 河北 石家庄 050051)

颈椎病是由于颈椎慢性病变或损伤, 造成的椎体缘唇样增生, 椎间隙变窄、椎间盘变性等, 使神经根、血管受压、扭曲、磨损, 发生的以颈部及肩臂疼痛、功能紊乱、甚至功能障碍为主要症候的病变。中医按主证不同, 可归属痹证、眩晕、头痛等不同病证中, 笔者以葛根汤加减治疗了105患者, 效果良好, 现将临床资料与体会报告如下:

1 临床资料

1.1 一般资料: 本组105例其中男59例, 女46例, 男女之比为1.3:1, 年龄在30岁以下者8例, 31~40岁者19例, 40~50岁者24例, 51岁以上者54例, 40岁以上中老年人占74%。病程在半年内者37例, 1~5年者53例, 5年以上者14例, 1年以上者占64%。

1.2 症状与体征: 本组病例临床症状主要表现为项颈强硬酸痛, 上肢麻、肩臂疼痛、眩晕头痛等。其中项颈强硬49例, 项颈酸痛70例, 两项合计95例(90%), 肩臂疼痛发麻55例(52%), 眩晕44例(42%), 头痛17例(16%)伴下肢无力、麻木2例, 汗出过多1例。查体: 颈部压痛61例(58%), 旋颈阳性54例(51%), 压颈阳性16例(15%), 活动障碍26例(25%), 高血压8例(8%)。

1.3 X线摄片检查: 全部病例均经X线摄片检查确诊, 87%的患者增生3节椎体以上, 且以下段为主。病变的程度, 根据X线报告, 单纯肥大者42例(40%), 伴椎间隙狭窄41例(39%), 伴项韧带、椎间盘钙化25例(24%), 伴椎间盘突出者1例, 骨桥形成者2例。

1.4 药物组成: 葛根、桂枝、赤芍、川草乌、威灵仙、川芎、土茯苓等, 酸楚甚加杜仲、川断, 疼痛剧加细辛, 三七粉, 有热象加大黄, 离子导入加麻黄。

1.5 治疗方法: 本组病例分2组, 一组口服煎剂, 日一剂, 分2次煎服, 渣用布包扎后趁热敷颈部, 另一组作中药离子导入, 治疗期间停用其他一切治疗。

1.6 治疗结果: 疗效观察标准分三级

1.6.1 显效: 症状和体征消失或基本消失, 恢复正常工作者。

1.6.2 有效: 症状明显减轻, 体征改善者。

1.6.3 无效: 症状减轻不明显或改善不大者。

结果: 显效26例(25%), 有效74例(70%), 无效6例, 总有效率95%。

2 体会

2.1 葛根汤出于《伤寒论》、《金匱要略》, 原为太阳病项背强证、刚痉的代表方。我们在选方时考虑到颈椎病既以项强痛为主证。受《伤寒论》“太阳病、项背强几几……葛根汤主之”及《金匱》“颈项强急……痉病也”“欲作刚痉, 葛根汤主之”启发, 遂决定以葛根汤为主方加减治之。

我们认为虽然颈椎病与太阳病项强证、刚痉不同, 一为内伤病, 一为外感病, 一先表证, 一有表证, 但两者之间也存在相似之处, 均以太阳经

所过之项为主要病位, 均以项强不舒为病证特点。在病理上虽言颈椎病为一慢性退行性病, 一般认为“肾主骨”乃肾虚骨失所养所致, 但据尸检统计, 50岁以上女性, 50岁以上男性, 有椎体骨刺者占90%, 而有临床症状者远没有这样高的比例, 有的颈椎增生和退行性变严重, 但并无临床症状, 而有临床症状者, 则常发生于损伤、受寒或长时间伏案工作之后。本组病例明确指出其发于外伤, 受寒之后者占1/4。近70%的患者就诊于冬春季节, 又从另一个侧面说明本病的发作或加剧与冬春的风寒之邪有关。其次, 占本组病例26%的青年患者经询问大多数并无肾虚的其他症状。故我们认为颈椎的增生与肥大, 虽主要在于肾虚, 但症状的产生则多由于有风湿湿之邪或淤血的阻滞, 使太阳经气血运行不畅, 筋脉失养, 故而发生足太阳经所过之头项、肩胛及与之有经络联系的手太阳经循行之手指、臂、肩、大椎等处部位的强硬、疼痛、麻木。而太阳病项背强证, 刚痉的发生也是由于风寒湿邪侵袭, 壅阻经络, 气血不利, 筋脉拘急而成, 不同的是尚有邪气郁于肌表而有表证, 故从某种意义、某个方面来说, 颈椎病与太阳病项强证、痉证在病理上也有相似之处。既然两者在病位、病理、症状上有类似之处, “异病同治”, 以葛根汤加减来治疗颈椎病于理也是可行的。

2.2 从方剂组成来看, 葛根汤乃桂枝汤加葛根、麻黄而成。方中桂枝、麻黄为太阳经药, 能发散通经, 祛风散寒解表。颈椎病因无表证故口服剂中我们去麻黄之解表发汗, 只取桂枝加上川草乌、威灵仙以通经散邪, 配合赤芍、川芎以活血通经。葛根乃阳明经药, 仲景为何要以此作为主药呢? 书中未说明, 而历代医家就此则大加发挥, 众说纷云。我们在选本方作为主方之前, 曾按痹证选方用药, 只是未用葛根。结果疗效欠佳, 才使我们转向葛根汤, 取得了较满意的效果, 故我们认为葛根是治疗项强痛的主药, 这是仲景从临床实践中总结出的宝贵经验, 是仲景留给我们的珍贵遗产。

2.3 关于眩晕, 并非太阳病项背强、刚痉的主证。按内科杂病风、火、痰、虚立论来治疗实践证明效果并不好。我们认为, 由于是太阳膀胱经从头顶入颅络脑, 回出来左右分开到项部, 风寒湿邪或淤血阻滞, 既可以因不通而发生疼痛, 也可因之脑失所养而眩晕, 只要邪去经通, 气血能上承于脑, 头晕头痛之症即可消除。本组病例中, 症状改善最快的是头晕, 疗效最好的也是头晕, 无效的6例中, 仅1例曾伴有头晕, 说明本方对消除改善颈椎病的眩晕证疗效是满意的。究其因, 我们认为也与葛根的药理作用有直接关系。据报道, 葛根能增加椎动脉血供, 改善脑血液循环, 故对颈椎病椎动脉受压, 脑供血不足引起的头晕有满意的疗效。

2.4 在应用本方时, 我们还有一个体会是疗程要长些, 一般治疗几天后症状就可以开始减轻, 但我们要求患者至少坚持治疗一个疗程(12d), 无效的都是未滿一疗程, 而显效的平均2疗程, 26例中有14例是坚持治疗3~4疗程的。一旦获得显效, 其症状复发的机会就很少。显效患者中有